Ce chapitre reprend les principes fondamentaux du secours à victimes tels qu'ils sont décrits dans les recommandations nationales relatives aux premiers secours en les adaptant aux règles propres de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

En secours et soins d'urgence aux personnes (SSUAP), les personnes prises en charge sont habituellement appelées « victimes ». Avant d'aborder leur prise en charge, il est important de définir les victimes à qui nous portons secours et les impliqués que nous côtoyons sur intervention.

Le terme « victime » a de nombreuses significations en fonction du périmètre étudié et n'a pas le même sens si l'on fait partie de la chaine des secours, ou de l'institution judiciaire par exemple. Il faut donc définir le périmètre d'action des sapeurs-pompiers.

Définitions

L'engagement des secours est codifié dans le BSP 115.

Une intervention **débute dès le traitement de l'appel** qui conduit à la sélection d'un Moyen Mobile Autonome (MMA) et s'achève par la rédaction d'un Rapport de Sortie de Secours (RSS) après avoir sélectionné un Compte-Rendu d'Intervention (CRI) Toute intervention donne lieu à la rédaction d'une Main Courante Opérationnelle (MCO).

A. Victime

En SSUAP, une victime est une personne présente et concernée par un événement ou un état qu'elle subit :

- soit elle présente des sensations anormales, qu'elle se sache ou non malade.
- soit elle a subi un traumatisme, quelles que soient les circonstances et qu'il soit physique ou psychologique, immédiat ou retardé.
- De ce fait, des personnes initialement considérées comme des impliquées peuvent donc secondairement être prises en charge en tant que victimes psychologiques d'un événement ;
- soit elle est intoxiquée ;
- soit elle est atteinte de maladies mentales (troubles du comportement, dépression, délire, menace de suicide ...). Dans ce cas les secours sont généralement demandés par un tiers et la personne doit être considérée comme une victime, même si elle le réfute ;
- soit c'est une parturiente (femme qui accouche).

Cas particuliers :

- Il peut arriver exceptionnellement que l'envoi des secours soit fait par sécurité mais que la personne :
  - ne présente aucune des caractéristiques ci-dessus ;
  - soit absente et introuvable ;
  - n'ait pas demandé les secours et ne relève pas d'une action de secours.

Dans ce cas, ce n'est pas une victime (= non-victime) car elle ne nécessite aucune action de secours de notre part (exemples : personne victime d'un vol et qui n'a pas subi d'agression physique, ni ne ressent le moindre malaise, personne qui dormait...). Il n'y a pas lieu de contacter la coordination médicale. **Le CRI est alors : 452.**

- Dans le cas d'une vulnérabilité identifiée (exemples : personne vivant dans la rue, conditions météorologiques, personne ayant sautée à l'eau pour sauver un noyé...),ou si un doute subsiste, il convient de réaliser un bilan et une fiche bilan avant de conclure qu'il ne s'agit pas d'une victime. Il n'y a pas lieu de contacter la coordination médicale. **Le CRI est alors : 451.**

B. Catégorisation des victimes

Les victimes sont catégorisées selon les critères suivants :

- Victime décédée (DCD) ;
- Si elle nécessite une action de secours urgente (gestes de secourisme, mise sous oxygène ...) et une possible évacuation, elle est catégorisée :
  - **Victime en urgence absolue (UA) :** lorsqu'elle présente un risque vital ou fonctionnel immédiat nécessitant des gestes de sauvegarde, des soins médicaux ou chirurgicaux sans délai ;
  - **Victime en urgence relative (UR) :** lorsqu'elle ne présente pas de risque vital ou fonctionnel immédiat :
    - qu'elle nécessite des soins et un transport, le plus souvent vers un service d'urgences ;
    - ou qu'elle puisse être laissée sur place en vue d'une consultation simple à domicile ou en ville, programmée ou non, si besoin avec transport privé ou personnel.
- Impliqué : personne qui n'a subi aucun dommage physique ou psychique immédiatement apparent, mais est directement liée à l'événement, compte tenu de sa proximité géographique avec des victimes.

C. Personne sauvée

Est considérée comme personne sauvée, toute personne soustraite à un péril immédiat, qu'il s'agisse d'une circonstance (incendie, AVP...) ou qu'il s'agisse d'une maladie ou d'un état.

En SSUAP certaines victimes UA, à n'importe quelle phase de l'intervention, sont des personnes sauvées. (Exemple : obstruction totale des voies aériennes par un corps étranger avec manœuvre de Heimlich guidée par l'opérateur au 18 ou réalisée par les premiers secours)

Ce sont les soins nécessaires qui déterminent la catégorisation et non les modalités de transport.

C'est donc l'état initial de la victime ou l'état le plus grave au cours de la prise en charge qui est pris en compte pour catégoriser la victime.

Les soins administrés sur les lieux peuvent réduire une UA en UR mais la catégorisation reste UA car au début de l'intervention elle présente une détresse vitale. Toute personne prise en charge et traitée par une équipe médicale est une UA. S'il arrive que l'équipe médicale transporte une personne UR, le médecin le précise au COS.

Une victime qui reste sur place contre l'avis du médecin garde son statut d'UA ou d'UR.

En cas de doute le médecin sur les lieux ou à la coordination médicale détermine la catégorisation.



Catégorisation : exemples non exhaustifs

- **Système respiratoire :**
  - Une personne qui présente une SpO2 AA < 90% à un moment de sa prise en charge est une UA.
  - Une personne qui a bénéficié d'un geste de désobstruction des voies aériennes est une UA même si, à l'arrivée des secours, le corps étranger a déjà été expulsé et qu'elle est transportée vers une structure d'urgence, voire qu'elle est laissée sur place. En effet, à l'appel des secours, elle était en danger de mort.
- **Système circulatoire :**
  - Une personne qui présente une Pression Artérielle Systolique < 90 mm Hg à un moment de sa prise en charge est une UA.
  - Une personne qui a bénéficié d'une manœuvre guidée pour réduire une tachycardie est une UA
  - Une personne qui a bénéficié de la pose d'un garrot est une UA, même si elle est transportée par un engin non médicalisé.
- **Système neurologique :**
  - Une personne qui présente un score de Glasgow < 14 est une UA.
  - Un diabétique dans le coma qui est resucré et se réveille est une UA car sans notre intervention il courait un risque vital, même si parfois on le laisse sur place
  - Une personne victime d'un AVC **transportée vers une Unité de Soins Intensifs Neuro Vasculaires (USINV) est une UA. En effet elle présente un risque fonctionnel,** voire vital à court terme, avec un besoin de désobstruction artérielle extrêmement urgent, raison pour laquelle un transport avec avertisseurs sonore et lumineux est prescrit.
- **Accouchement :**
  - Une femme qui accouche hors de la maternité et son nouveau-né vivant sont des UA.
  - Une femme enceinte qui accouche juste après l'arrivée à la maternité est une UA, que les transmissions soient faites ou non. Elle bénéficie d'un transport avec avertisseurs sonore et lumineux pour éviter l'accouchement préhospitalier.
  - Une personne présumée UR qui s'aggrave brutalement voire fait un arrêt cardiaque aux urgences, alors que l'équipe de SP n'a pas encore quitté les lieux, est une UA, que les transmissions soient faites ou non.